PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución del Ministerio de Salud: nomenclador del Programa SUMAR+ con pago por control efectivo de hipertensión y diabetes

Incorpora al plan de prestaciones del Programa SUMAR+ el pago semestral al centro de cabecera por cada persona con hipertensión o diabetes efectivamente controlada, sobre la asignación nominal de cada persona a un centro, con la meta de 50 % de los hipertensos y diabéticos asignados con control registrado al fin de la Fase II.

Propuesta 80: Salud: médico de cabecera, hospitales y turnos a tiempo
Cuándo: Fase I
Trámite: No aplica: resolución del Ministerio de Salud (modifica el Manual y Reglamento Operativo del SUMAR+).

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° 26.529, la Ley N° 25.326, la Resolución Conjunta N° 1/2024 de la Secretaría de Acceso y Equidad en Salud, la Resolución del Ministerio de Salud N° 1445 del 14 de octubre de 2026, y

CONSIDERANDO:

Que el Programa SUMAR+ registra a la población con cobertura pública exclusiva y transfiere recursos a las jurisdicciones para pagar a los centros de salud por las prestaciones brindadas, conforme el Manual y Reglamento Operativo aprobado por la Resolución Conjunta N° 1/2024 de la Secretaría de Acceso y Equidad en Salud.

Que la Resolución del Ministerio de Salud N° 1445/2026 aprobó el Plan Nacional de Abordaje Integral de Salud Vascular 2026-2030, que se propone traducir progresivamente sus intervenciones en prestaciones concretas del sistema de salud, y que corresponde fijarle metas numéricas y definir las prestaciones que se pagan.

Que las enfermedades crónicas no transmisibles son las principales causas de muerte en el país y se controlan mejor en el primer nivel de atención, cerca de cada persona, que en una guardia.

Que el treinta y cinco coma ocho por ciento (35,8 %) de la población depende solo del sistema público de salud, según el Censo 2022.

Que pagar por control efectivo, y no solo por consulta, orienta a los equipos de cabecera hacia el resultado que importa para la salud de cada persona.

Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias.

Por ello, EL MINISTRO DE SALUD RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Nuevas prestaciones. Incorpóranse al plan de prestaciones pagadas del Programa SUMAR+ las prestaciones «Control efectivo de hipertensión arterial» y «Control efectivo de diabetes mellitus tipo 2», con el alcance de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Asignación a un centro de cabecera. Cada persona inscripta en el Programa SUMAR+ queda asignada a un centro de salud del primer nivel y a su equipo de cabecera, según su domicilio o su elección. Las prestaciones del artículo anterior se pagan al centro al que la persona está asignada.

ARTÍCULO 3°.- Población comprendida. Las prestaciones comprenden a las personas de dieciocho (18) años o más inscriptas en el Programa con diagnóstico registrado de hipertensión arterial o de diabetes mellitus tipo 2.

ARTÍCULO 4°.- Control efectivo de hipertensión arterial. Se considera que hubo control efectivo de hipertensión arterial en un semestre cuando la persona tuvo al menos dos (2) controles registrados con valores de presión arterial y el último valor registrado fue inferior a ciento cuarenta (140) milímetros de mercurio de presión sistólica y a noventa (90) de presión diastólica.

ARTÍCULO 5°.- Control efectivo de diabetes. Se considera que hubo control efectivo de diabetes mellitus tipo 2 en un semestre cuando la persona tuvo al menos dos (2) controles registrados y una determinación de hemoglobina glicosilada con resultado inferior al ocho por ciento (8 %).

ARTÍCULO 6°.- Valor y pago. Cada prestación se paga una vez por semestre y por persona, por el valor que fija la Secretaría de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud en la tabla de prestaciones del Programa, a través de las transferencias a las jurisdicciones y conforme los procedimientos de validación y auditoría del Manual y Reglamento Operativo.

ARTÍCULO 7°.- Metas. Fíjase como meta que el cincuenta por ciento (50 %) de las personas con hipertensión arterial o diabetes asignadas a un centro de cabecera tenga control registrado al 10 de diciembre de 2030, con metas intermedias del veinte por ciento (20 %) al 10 de diciembre de 2028 y del treinta y cinco por ciento (35 %) al 10 de diciembre de 2029. Las metas forman parte del Plan Nacional de Abordaje Integral de Salud Vascular 2026-2030.

ARTÍCULO 8°.- Información pública. El Ministerio de Salud publica cada semestre, por jurisdicción, la cantidad de personas asignadas a un centro de cabecera, la de personas con hipertensión o diabetes con control registrado y la de personas con control efectivo, sin datos que permitan identificar a ninguna persona.

ARTÍCULO 9°.- Datos. Los datos clínicos se registran en la historia clínica y en el sistema de información del Programa, con la confidencialidad que exigen la Ley N° 26.529 y la Ley N° 25.326, y se usan solo para la atención, la liquidación de las prestaciones y la elaboración de indicadores.

ARTÍCULO 10°.- Adecuación. La Secretaría de Gestión Sanitaria adecua, dentro de los sesenta (60) días de la publicación de la presente, el Manual y Reglamento Operativo aprobado por la Resolución Conjunta N° 1/2024 y los compromisos anuales de gestión con las jurisdicciones, e incorpora las metas del artículo 7°.

ARTÍCULO 11°.- Gastos. Los gastos que demande la presente se atienden con los créditos asignados al Programa SUMAR+.

ARTÍCULO 12°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app